Atelier fisioterapia

MC ANNO 2026/2027

Evidence Based Practice (EBP)

composta da:

- best scientific Evidence
- patient values: i valori e capacità del paziente, ci prendiamo a carico tutta la persona
- clinical experience: esperienza su diagnosi e cure passate molto utili

Piramide delle evidenze

Non tutta l'evidenza scientifica vale allo stesso modo dal meno al piu qualitativo

- informazioni di background, opinione dell'esperto (per quanto formata, non è oggettiva)
- casi individuali: caso speciale che vediamo da qualche parte, vediamo magari pure un report, ma non ha validità
- studio di caso
- cohort study
- non randomized control trials
- randomized control trials (campioni di persone divisi casualmente)
- letteratura con pratiche evidence based
- systematic review (mettere assieme diversi studi e letteratura)
- Meta analisi: prendono diversi concetti su un argomento e fanno una "mega" analisi

Importanza dell'EBP

- Le linee guida cambiano: nuove evidenze e nuove raccomandazioni
- Diritto del paziente a decisioni informate: Esperienza clinica da sola non basta. Il paziente ha diritto a cure aggiornate
- Responsabilità professionale: il professionista sanitario ha l'obbligo etico di tenersi aggiornato

Come scegliere le evidenze

spin = distorsione nella comunicazione dei fatti Succede quando un ricercatore, ufficio stampa, giornale ecc, presenta risultati di uno studio in modo da far sembrare il trattamento piu efficace di quanto i dati supportano

- tabloid: assolutamente inaffidabili
- siti istituzionali: piu accurati dei tabloid, utile per orientamento sul tema, non riporta risultati grezzi, non ha occhio clinico, non sostituisce letteratura scientifica
- studio scientifico: accurato e utile se interpretato con cura

Il modello biopsicosociale

IL PAZIENTE È MOLTO DI PIU DELLA SUA DIAGNOSI

> *"Il modello biopsicosociale non è solo una checklist, è una maniera completamente diversa di concepire la malattia"* Engel, 1977

Composto da diversi aspetti:

- Biologico: salute fisica, vulnerabilità genetica, effetti di sostanze
- Sociale: pari, circostanze e relazioni familiari
- Psicosociale: Salute fisica, Skill di accettazione, skill sociali, relazioni familiari, self esteem, salute mentale

Il dolore

Il cervello interpreta il dolore. Noi possiamo andare ad agire

Sentire male non significa perforza che qualcosa si sta rompendo

> Definizione IASP: esperienza sensoriale ed emozionale associata con un effettivo o potenziale danno tessutale

Il dolore può essere considerato un allarme

Quando il cervello percepisce un danno o la minaccia di un danno si sente dolore

- il dolore serve quindi a motivare un azione per proteggere il corpo
- il dolore è sempre creato dal cervello, ma questo non vuol dire che sia nella tua testa
- il dolore quindi non è indicativo di un danno. ci segnala che qualcosa non va ma non è sufficientemente preciso per dirci quando sia grave il problema
- soprattutto quando il dolore persiste da molto tempo, la relazione tra dolore e danno è molto debole

Teoria

- Il **nocicettore** sente lo stimolo chimico, meccanico, termico
- questi recettori inviano dei segnali di pericolo dal nostro corpo al **midollo spinale**
- Il midollo spinale può essere considerato come un centralinista che dopo aver elaborato un'informazione la può inviare al cervello

Regolazione del dolore

- **Regolazione periferica**: quando il tessuto è danneggiato, i nocicettori periferici diventano più sensibili: questo si chiama sensibilizzazione periferica
- **Regolazione centrale**: in base all'inibizione discendente o alle facilitazioni dal cervello, il midollo spinale può modificare la sua sensibilità e alterare la quantità di segnale che invia al cervello → il midollo spinale puo quindi comportarsi come un megafono oppure come un riduttore per il dolore

Il dolore viene influenzato molto secondo il modello psicosociale → possiamo andare a intervenire su diversi aspetti

Scale di misurazione

misure di autovalutazione, da 0-10, con faccine Scala McGill approfondisce la qualità del dolore (pungente, a morso, lancinante, ...)

Primo intervento in caso di infortunio

PEACE AND LOVE **P**rotection **E**levation **A**void anti inflammatory **C**ompression **E**ducation **&** **L**oad **O**ptimism **V**ascularization **E**xercise

Cos'è la fisioterapia

- Il fisioterapista ripristina, sviluppa o mantiene il movimento delle abilità funzionali della persona durante le varie fasi della vita
- Offre interventi in caso che delle funzioni per l'attività quotidiana, professionale o sportiva risultino compromessi o minacciati
- Identificare e massimizzare il potenziale di movimento nell'ottica della promozione e prevenzione della salute
- Educare in merito a disturbi, dolore, caratteristiche dell'approccio fisioterapico

Il processo fisioterapico:

- assessment: capire che problema ha
- pianificazione d'intervento

- implementare intervento
- evaluation
- scarico del paziente

Ambienti di specializzazione

- cardiorespiratorio
- geriatrico
- muscoloscheletrico
- neurologico
- pediatrico
- gestione del dolore
- sport ed esercizio
- pavimento pelvico
- oncologico
- cure palliative
- reumatologico
- vestibolare
- salute mentale

Importanza del team multidisciplinare. Non si puo essere esperti in tutto Top 3 sono fisi, ergo, infermieristica

Mobilitazione

Significa in poche parole muovere. Può essere inteso sia a livello globale (il paziente si alza, cammina, durante un transfer), o puntuale/articolare

- Attiva, attiva assistita, passiva
- Recupero della mobilità articolare
- Recupero della funzione muscolare
- Diminuzione del dolore (stimolo dei meccanocettori inibisce stimolo del dolore)
- Evitare zone di pressione, decubiti, accorciamenti muscolari specialmente nei pazienti allettati
- Ricondizionamento